

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO BREVE DE AFRONTAMIENTO (BRIEF COPE)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Multidimensional de Estrategias de Afrontamiento ante el Estrés

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario Breve de Estrategias de Afrontamiento (Brief COPE).
Nombre Original (Inglés)	<i>Brief COPE (Coping Orientation to Problems Experienced)</i>
Autor Original	Dr. Charles S. Carver (1997), University of Miami.
Adaptaciones Españolas	Morán et al. (2010); Crespo & Cruzado (2014); Perczek et al. (2000).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Transaccional de Estrés y Afrontamiento (Lazarus & Folkman).
Tipo de Instrumento	Autoinforme multidimensional de 28 reactivos con escala Likert de 4 anclajes (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes (≥ 14 años) y adultos. Pacientes médicos crónicos, psiquiátricos y población general.
Tiempo de Administración	4 a 7 minutos en autoadministración; 8 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico de acceso público para fines clínicos y académicos de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS

El Brief COPE constituye la versión abreviada y refinada del inventario COPE original de 60 ítems (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Fundamentado en el modelo transaccional de estrés de Lazarus y Folkman combinado con la teoría de autorregulación de Carver y Scheier, el instrumento evalúa las respuestas cognitivas, afectivas y conductuales concretas que una persona despliega cuando se enfrenta a acontecimientos vitales estresantes o demandas ambientales desbordantes.

A nivel neurobiológico y funcional, el afrontamiento representa el esfuerzo cognitivo ejecutivo mediado por la corteza prefrontal dorso-lateral y el córtex orbitofrontal para modular la respuesta alostática disparada por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HPA). El inventario permite discriminar con gran finura entre estilos adaptativos (centrados en el problema y en la resignificación emocional, que favorecen la resiliencia fisiológica) y estilos evitativos o desadaptativos (desconexión, negación, autoculpabilización y abuso de tóxicos), los cuales perpetúan el estrés crónico y predicen mala evolución psicopatológica.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Macro-Categoría	Subescalas (14)	Ítems	Definición Operativa del Afrontamiento
1. Centrado en el Problema	Afrontamiento Activo Planificación	1 y 7 14 y 25	Esfuerzos directos para resolver el estresor, estructurar planes y tomar iniciativas conductuales concretas.
2. Centrado en la Emoción	Apoyo Emocional Desahogo Humor Religión	5 y 15 9 y 21 18 y 28 16 y 22	Búsqueda de contención afectiva, expresión de emociones sentidas, reinterpretación humorística y recursos espirituales.
3. Significado / Adaptativo	Reencuadre Positivo Aceptación Apoyo Instrumental	12 y 17 20 y 24 10 y 23	Búsqueda del lado positivo de la vivencia, aceptación de la realidad irremediable y solicitud de consejo u orientación técnica.
4. Evitativo / Desadaptativo	Negación Desconexión Conductual Uso de Sustancias Autoculpa Autodis-tracción	3 y 8 6 y 13 4 y 11 26 y 27 2 y 19	Tentativas de rechazar la realidad, renuncia a metas, ingesta de alcohol/fármacos, autorreproche destructivo y evasión pasiva.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Alfas de Cronbach adecuadas para subescalas de 2 ítems: oscilan entre 0.65 y 0.88 en adaptaciones españolas (Morán et al., 2010; Crespo & Cruzado, 2014); destacando sustancias (0.87), religión (0.85) y afrontamiento activo (0.76).
Estructura Factorial	Los análisis de segundo orden agrupan consistentemente las 14 escalas en tres factores superiores: Afrontamiento Centrado en el Problema, Afrontamiento Emocional Adaptativo y Afrontamiento Evitativo/Pasivo.
Validez Concurrente	Las subescalas evitativas (desconexión, autculpa, sustancias) correlacionan positivamente con ansiedad (BAI, $r = 0.52$), depresión (BDI-II, $r = 0.58$) y distrés; las activas correlacionan con resiliencia y salud mental.
Estabilidad y Plasticidad	Presenta estabilidad disposicional moderada ($r = 0.62$ a 6 semanas) pero alta sensibilidad a programas de inoculación de estrés, psicooncología y terapia cognitivo-conductual.
Invarianza Clínica	Invarianza demostrada en población oncológica, cuidadores de demencias y muestras comunitarias.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se responde en una escala de 4 puntos según la frecuencia de uso habitual ante el estresor: **1** = «Casi nunca / Nunca hago esto», **2** = «Pocas veces», **3** = «A menudo», **4** = «Casi siempre».

- **Cálculo por Subescala (14 escalas):** Se suman los 2 reactivos de cada escala. Rango por subescala: **2 a 8 puntos**.
- **Macro-Puntuaciones de Segundo Orden (Opcional):**
 - *Afrontamiento Activo/Adaptativo:* Suma de Activo + Planificación + Reencuadre + Aceptación + Apoyos (Rango: 12 a 48).
 - *Afrontamiento Evitativo/Desadaptativo:* Suma de Negación + Desconexión + Sustancias + Autculpa (Rango: 8 a 32).
- **Regla Metodológica:** No se calcula un sumatorio total universal, sino un perfil tipificado de estrategias.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PERFILES DE AFRONTAMIENTO

Rango Escalar	Puntuación	Significación Clínica	Dirección de la Intervención Terapéutica
Uso Mínimo	2 a 3 puntos	Estrategia ignorada o infrecuente	Si es activa: entrenar la habilidad. Si es desadaptativa: ausencia de riesgo en esa vía específica.
Uso Moderado	4 a 5 puntos	Estrategia de empleo contingente	Mecanismo secundario; valorar si se implementa de manera oportuna según el tipo de estresor.
Uso Predominante	6 a 8 puntos	Estrategia rectora habitual	Si es activa: reforzar repertorio. Si es evitativa (corte ≥ 6 en desconexión o autculpa): foco terapéutico prioritario.

CRITERIO DE AJUSTE ADAPTATIVO (BONDAD DE AJUSTE DE LAZARUS):

El afrontamiento no es intrínsecamente patológico o saludable, sino contextual: en situaciones modificables (ej. problemas laborales), el afrontamiento centrado en el problema reduce la morbilidad; en situaciones inmodificables (ej. pérdida de un ser querido, diagnóstico oncológico incurable), la aceptación y el reencuadre positivo son los mediadores de salud más potentes.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN MANEJO DEL ESTRÉS

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN BASADOS EN EL PERFIL BRIEF COPE:

- **Paso 1: Identificación de Marcadores Evitativos Tóxicos:** Si Desconexión Conductual ≥ 6 o Autoculpa ≥ 6 , intervenir de inmediato en detención de rumiación, autocuidado compasivo y reenganche conductual pautado.
- **Paso 2: Evaluación de Consumo:** Si Uso de Sustancias ≥ 4 , despistar abuso tóxico encubierto (alcohol/ansiolíticos) como regulador químico del estrés. Derivación o abordaje adictológico concurrente.
- **Paso 3: Potenciación de Estrategias Faltantes:** Entrenar Resolución de Problemas estructurada si Planificación ≤ 3 ante problemas modificables; entrenar Terapia de Aceptación o Reestructuración si Aceptación ≤ 3 ante estresores crónicos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: AFRONTAMIENTO EN DUELO Y SOBRECARGA FAMILIAR

Paciente: Mujer de 46 años, cuidadora principal de su madre con demencia avanzada, acude a consulta médica por cefaleas tensionales diarias, labilidad afectiva y consumo nocturno creciente de ansiolíticos sin prescripción.

Perfil del Brief COPE Inicial:

- **Subescalas Evitativas:** Autoculpabilización = **8 / 8 puntos** (ítems 26 y 27 = 4; culpa constante); Desconexión conductual = **7 / 8 puntos**; Negación = **6 / 8**; Uso de sustancias = **7 / 8** (automedicación).
- **Subescalas Adaptativas:** Apoyo instrumental = **2 / 8 puntos** (incapacidad para pedir ayuda externa); Aceptación = **3 / 8**; Reencuadre = **2 / 8**.

Formulación Clínica: La paciente exhibe un estilo de afrontamiento evitativo-destructivo. Intenta asumir en soledad una carga física inasumible, recurriendo al alcohol y sedantes para apagar la angustia mientras se flagela con autorreproches morales.

Tratamiento y Resultados: Intervención psicooncológica/cuidador de 10 sesiones: desmantelamiento de la culpa omnipotente, activación de red de apoyo formal (centro de día para la madre) y entrenamiento en asertividad. A los 3 meses: Autoculpa descendió a **3**, Desconexión a **2**, Sustancias a **2**, y Apoyo instrumental subió a **7**. Remisión del consumo y estabilización de la tensión arterial.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

ALERTA: AUTOCULPABILIZACIÓN ELEVADA (ÍTEMS 26 Y 27)

Puntuaciones de 7 u 8 en Autoculpabilización correlacionan fuertemente con desesperanza clínica y riesgo autolítico encubierto. Requiere despistaje inmediato mediante escalas de riesgo de suicidio (C-SSRS).

USO DE SUSTANCIAS (ÍTEMS 4 Y 11)

Cualquier puntuación ≥ 4 en la subescala de sustancias obliga a valorar dependencia química o automedicación compulsiva de hipnóticos y alcohol como conducta de seguridad primaria.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol's too long: Consider the Brief COPE. *International Journal of Behavioral Medicine*, 4(1), 92–100.
2. Morán, C., Landero, R., & González, M. T. (2010). COPE-28: un análisis psicométrico de la versión en español del Brief COPE. *Universitas Psychologica*, 9(2), 543–552.
3. Crespo, M., & Cruzado, J. A. (2014). La evaluación del afrontamiento: adaptación española del cuestionario COPE con una muestra de estudiantes universitarios. *Análisis y Modificación de Conducta*, 40, 45–66.
4. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.